

Hiperplasia prostática benigna (HPB)

1. Introducción y relevancia clínica

La **hiperplasia prostática benigna (HPB)** es una de las patologías más frecuentes en el varón adulto mayor. Se define como el **crecimiento benigno del estroma y epitelio prostático**, que ocurre principalmente en la **zona de transición** y que puede causar **obstrucción del tracto urinario inferior (OTUI)**.

Su prevalencia aumenta con la edad:

- 50% de los hombres a los 60 años presentan aumento del volumen prostático.
- Hasta 90% a los 85 años tienen algún grado de obstrucción urinaria.

La HPB **no es una lesión precancerosa**, pero puede coexistir con cáncer de próstata.

Su relevancia clínica radica en que es una causa **muy frecuente de síntomas urinarios** y de **complicaciones obstructivas** como la retención aguda de orina, hidronefrosis e insuficiencia renal.

□ En el **EUNACOM**, este tema suele evaluarse con preguntas sobre:

- Diagnóstico clínico del síndrome prostático.
- Interpretación de flujometría y tacto rectal.
- Indicaciones de tratamiento farmacológico o quirúrgico.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La HPB es un **proceso proliferativo benigno** dependiente de andrógenos, especialmente de la **dihidrotestosterona (DHT)**.

2.1. Mecanismos fisiopatológicos

1. **Conversión de testosterona en DHT** por la enzima **5 α -reductasa tipo II** en las células prostáticas.

2. La DHT se une a receptores nucleares, promoviendo la proliferación celular estromal y glandular.
 3. El crecimiento prostático ocurre principalmente en la **zona periuretral**, generando **compresión del lumen uretral**.
 4. Se produce una **obstrucción mecánica y funcional**, que con el tiempo lleva a **hipertrofia del detrusor** y alteración del vaciamiento vesical.
-

2.2. Fisiología prostática normal

La próstata es una glándula dependiente de andrógenos, cuya función principal es producir parte del líquido seminal.

Su tamaño normal en adultos jóvenes es de **15–25 g**, y el crecimiento prostático con la edad se debe al desequilibrio entre **proliferación y apoptosis celular**.

2.3. Componentes del síndrome prostático

- **Componente mecánico:** crecimiento estructural de la glándula que comprime la uretra.
- **Componente dinámico:** tono muscular aumentado del estroma prostático mediado por receptores adrenérgicos $\alpha 1$.

Ambos determinan el **síndrome prostático obstructivo y/o irritativo**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas del tracto urinario inferior (STUI)

Se dividen en **dos grupos**:

A. Síntomas obstructivos (vaciamiento):

- Disminución del calibre o fuerza del chorro urinario.
- Vacilación (inicio retardado de la micción).

- Goteo postmiccional.
- Micción intermitente o prolongada.
- Sensación de vaciamiento incompleto.

B. Síntomas irritativos (almacenamiento):

- Polaquiuria diurna.
- Nicturia.
- Urgencia miccional.
- Incontinencia de urgencia.

☐ En el EUNACOM, estos síntomas se agrupan bajo el **síndrome prostático**.

3.2. Evaluación clínica

- **Historia clínica detallada:** inicio, progresión y severidad.
 - **Cuestionario IPSS (International Prostate Symptom Score):**
 - 7 ítems (0 a 5 puntos cada uno).
 - Clasificación: leve (0–7), moderado (8–19), severo (20–35).
 - **Exploración física:**
 - **Tacto rectal digital (TRD):**
 - Evalúa tamaño, consistencia y simetría.
 - En HPB: próstata **umentada, lisa, elástica y no dolorosa**.
 - En cáncer: **nódulo duro, irregular o asimétrico**.
-

3.3. Diagnóstico diferencial

Patología	Rasgos distintivos
Cáncer de próstata	Nódulo duro en TRD, PSA elevado >10 ng/mL.
Prostatitis crónica	Dolor perineal, fiebre, sensibilidad al TRD.
Estenosis uretral	Antecedente de instrumentación o infección uretral.
Vejiga neurógena	Antecedente neurológico, residuo elevado sin obstrucción.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Estudios de primera línea

- **Uroanálisis y urocultivo:** descartan infección urinaria.
 - **Creatinina plasmática:** evalúa repercusión renal.
 - **Antígeno prostático específico (PSA):**
 - HPB: puede estar levemente elevado (<4–10 ng/mL).
 - Elevaciones mayores requieren descartar cáncer.
 - **Ecografía prostática transrectal o abdominal:**
 - Evalúa volumen prostático (>30–40 g sugiere HPB significativa).
 - Estima residuo postmiccional (>100 mL = mal vaciamiento).
 - **Flujometría urinaria:**
 - Flujo máximo (Qmax) <10 mL/s sugiere obstrucción.
-

4.2. Estudios complementarios (según caso)

- **Urodinamia:** si sospecha de vejiga neurogénica o síntomas discordantes.
 - **Cistoscopia:** si hematuria o sospecha de estenosis uretral.
 - **Biopsia prostática:** solo ante sospecha de cáncer (TRD o PSA alterado).
-

4.3. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de HPB se realiza con:

1. **Síntomas del tracto urinario inferior.**
 2. **TRD compatible.**
 3. **Exámenes que descartan otras causas (uroanálisis, PSA, ecografía).**
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL Chile 2022 y EAU 2023)

El manejo depende de la **gravedad de los síntomas**, la **repercusión sobre la calidad de vida** y la **presencia de complicaciones**.

5.1. Medidas generales

- Evitar consumo excesivo de líquidos nocturnos.
 - Disminuir café, alcohol y medicamentos con efecto anticolinérgico.
 - Tratar constipación.
 - Reevaluación periódica cada 6–12 meses en casos leves.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Bloqueadores α 1-adrenérgicos

- **Ejemplos:** tamsulosina, doxazosina, alfuzosina.
- **Mecanismo:** relajación del músculo liso prostático y vesical $\rightarrow$ $\downarrow$ resistencia uretral.
- **Inicio de acción:** 48–72 h.
- **Efectos adversos:** hipotensión ortostática, eyaculación retrógrada.

Primera elección en síntomas moderados a severos sin aumento importante del volumen prostático.

B. Inhibidores de la 5 α -reductasa

- **Ejemplos:** finasteride, dutasteride.
- **Mecanismo:** inhiben conversión de testosterona a DHT $\rightarrow$ reducción del volumen prostático (~20–30%).
- **Indicaciones:** próstata >40 g, PSA >1,5 ng/mL, tratamiento a largo plazo.
- **Efectos secundarios:** $\downarrow$ libido, disfunción eréctil, ginecomastia.

Actúan lento (3–6 meses), pero reducen riesgo de retención urinaria y cirugía.

C. Terapia combinada

- Asociación de **bloqueador α 1 + inhibidor 5 α -reductasa:**

 - Mayor eficacia sintomática y menor progresión.
 - Indicada en HPB moderada-severa con próstata grande.

D. Antimuscarínicos / β 3 agonistas

- Utilizados si predominan síntomas irritativos (vejiga hiperactiva).
- Ejemplos: oxibutinina, mirabegrón.
- Requieren precaución si hay alto residuo postmiccional.

5.3. Tratamiento quirúrgico

Indicaciones absolutas:

- Retención urinaria aguda recurrente.
- Infecciones urinarias repetidas.
- Hematuria macroscópica persistente.
- Litiasis vesical secundaria.
- Hidronefrosis o insuficiencia renal postobstructiva.
- Fracaso del tratamiento médico.

Técnicas quirúrgicas:

1. **RTU de próstata (resección transuretral):**
 - Estándar en HPB moderada-severa (volumen <80 g).
 - Complicaciones: sangrado, eyaculación retrógrada, estenosis uretral.
2. **Adenomectomía abierta (suprapúbica o retropúbica):**
 - Para próstatas >80 g.
3. **Técnicas mínimamente invasivas:**
 - Vaporización láser, enucleación láser (HoLEP), termoterapia.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Manejo
Retención aguda de orina	Obstrucción completa	Cateterización y tratamiento farmacológico o quirúrgico

Infección urinaria	Estasis urinaria	Antibióticos dirigidos
Hematuria	Congestión prostática o RTU	Evaluar coagulopatía y descartar cáncer
Insuficiencia renal postobstructiva	Obstrucción bilateral o prolongada	Desobstrucción gradual
Disfunción sexual	Efecto adverso farmacológico o quirúrgico	Ajuste terapéutico

Pronóstico:

Excelente con tratamiento adecuado.

La mayoría de los pacientes mejora significativamente su calidad de vida con manejo médico o quirúrgico oportuno.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Síntomas del tracto urinario inferior ≠ diagnóstico de HPB** (descartar cáncer).
2. **TRD normal y PSA bajo → HPB probable.**
3. **Bloqueadores $\alpha 1$ → alivio rápido; inhibidores 5α → reducción a largo plazo.**
4. **Próstata >80 g → cirugía abierta o láser.**
5. **Retención urinaria recurrente = indicación quirúrgica.**
6. **PSA elevado → siempre descartar cáncer antes de tratar como HPB.**
7. **Anticolinérgicos solo si residuo postmiccional <100 mL.**



Errores comunes

- Iniciar tratamiento sin descartar infección o cáncer.
- Usar antimuscarínicos en pacientes con vaciamiento deficiente.
- No evaluar creatinina ni residuo postmiccional antes del tratamiento.
- Mantener sonda vesical prolongada sin indicación.
- No controlar PSA durante el seguimiento.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **HPB = crecimiento benigno periuretral que causa obstrucción urinaria.**
2. **Diagnóstico clínico:** síntomas + TRD + exclusión de otras causas.
3. **Tratamiento inicial:** bloqueadores $\alpha 1$ y medidas generales.
4. **Inhibidores 5α -reductasa:** reducen volumen prostático y progresión.
5. **Cirugía indicada** en complicaciones o fracaso médico.
6. **PSA y TRD siempre deben evaluarse para descartar cáncer.**
7. **Pronóstico excelente** con tratamiento adecuado y seguimiento regular.